AMBULATÓRIO INTEGRADO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA CLÍNICA — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-005)

Laudo Clínico e Metabólico: Nefropatia Diabética Crônica Estágio 3b e Hipertensão Secundária

ID Prontuário:	**DOC-MED-005**	**Paciente:**	**P-05 (Roberto Almeida Figueiredo)**	**Idade / Sexo:**	61 anos | Masculino
Antropometria:	92 kg | 1,75 m (IMC: 30,0 kg/m² - Obesidade Grau I)	**Data/Hora:**	12/11/2026 - 11:30h	**Código CID-10:**	**E11.2 (Diabetes mellitus não-insulino-dependente com complicações renais)**

Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia): Diagnóstico Canônico: Nefropatia Diabética Crônica (Aliases: Doença Renal do Diabetes, Doença Renal Crônica Diabética). Causas: Diabetes Mellitus Tipo 2 (Aliases: DM2) e Hipertensão Arterial Sistêmica (Aliases: HAS, Pressão Alta). Fármacos: Metformina (Aliases: Glifage), Losartana Potássica.

1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente masculino, 61 anos, comerciante, comparece à avaliação nefrológica conjunta devido à piora progressiva da função renal, fadiga crônica aos esforços habituais, noctúria (3 a 4 episódios por noite), urina intensamente espumosa e edema simétrico de membros inferiores (cacifo ++/4+) vespertino há 3 meses.

Apresenta diagnóstico pregresso de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) há 14 anos com controle glicêmico historicamente precário, associado a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS / Pressão Alta) há 12 anos e retinopatia diabética não-proliferativa leve ao exame de fundo de olho.

2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

Parâmetro Clínico / Exame de Imagem	Achados Objetivos e Descrição Propedêutica
Sinais Vitais	PA: 154/96 mmHg | FC: 78 bpm | FR: 16 irpm | SpO2: 97% | Circunferência Abdominal: 108 cm
Exame Cardiovascular e Periférico	Bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos. Edema maleolar e pré-tibial bilateral simétrico (++/4+), pulsos pediosos palpáveis porém reduzidos.
Exame Neurológico Periférico	Hiporreflexia aquileia bilateral e redução da sensibilidade vibratória e tátil protetora ao monofilamento de Semmes-Weinstein 10g em região plantar (neuropatia periférica associada).
Ultrassonografia Renal com Doppler	Rins tópicos de dimensões normais (RD: 10,8 cm; RE: 10,6 cm), com aumento difuso da ecogenicidade cortical e preservação parcial da diferenciação corticomedular, sem hidronefrose.

3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

Exame / Biomarcador Analisado	Resultado Obtido no Paciente	Valor de Referência / Interpretação
Glicemia de Jejum / Hemoglobina Glicada (HbA1c)	**214 mg/dL / HbA1c: 8,9%**	70 - 99 mg/dL / HbA1c < 7,0% (Descompensado)
Creatinina Sérica / Ureia	**1,76 mg/dL / 68 mg/dL**	0,7 - 1,2 mg/dL
Taxa de Filtração Glomerular Estimada (CKD-EPI)	**41 mL/min/1,73m² (Estágio G3b)**	> 90 mL/min/1,73m²
Relação Albumina/Creatinina Urinária (RAC)	**480 mg/g (Macroalbuminúria Estágio A3)**	< 30 mg/g
Potássio Sérico / Bicarbonato Venoso	**4,8 mEq/L / HCO3: 22 mEq/L**	3,5 - 5,1 mEq/L
Proteinúria de 24 horas	**1.120 mg / 24h**	< 150 mg / 24h

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

A Nefropatia Diabética Crônica (Doença Renal do Diabetes) instala-se como complicação microvascular direta da hiperglicemia crônica do Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) potencializada pela pressão intraglomerular elevada da Hipertensão

Arterial Sistêmica (HAS). A glicação não-enzimática de proteínas (produtos finais de glicação avançada - AGEs) provoca espessamento da membrana basal glomerular, expansão mesangial (glomeruloesclerose nodular de Kimmelstiel-Wilson), perda de podócitos e proteinúria progressiva.

5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Controle Glicêmico Ajustado à Função Renal: Manutenção de Cloridrato de Metformina (Glifage) em dose reduzida para 500 mg VO 12/12h (devido à TFGe entre 30 e 45 mL/min) associada a inibidor de SGLT2 (Dapagliflozina 10 mg/dia) para redução da hiperfiltração glomerular.

2. Bloqueio do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (Nefroproteção): Prescrição de Losartana Potássica 50 mg VO de 12/12h visando vasodilatação da arteríola eferente glomerular, redução da proteinúria e controle estrito da pressão arterial (< 130/80 mmHg).

3. Monitoramento Metabólico: Restrição proteica moderada (0,8 g/kg/dia), restrição de sódio (< 2 g/dia) e acompanhamento trimestral da taxa de filtração glomerular.

[ALERTA DE GRAFO KAG - INTERAÇÃO COM CONTRASTE E ETIOLOGIA COMPARTILHADA]:

• Risco de Acidose Lática Induzida por Contraste Iodado (Conexão Multi-hop com DOC-MED-001): Pacientes portadores de Nefropatia Diabética Crônica em uso de Metformina (Glifage) apresentam risco crítico caso precisem realizar procedimentos hemodinâmicos com Meio de Contraste Iodado, como a Angioplastia Coronariana descrita no Infarto Agudo do Miocárdio (DOC-MED-001). O contraste iodado pode induzir nefropatia aguda transitória, impedindo a excreção renal da Metformina e provocando acúmulo plasmático tóxico que resulta em Acidose Lática grave (mortalidade > 30%). A Metformina deve ser obrigatoriamente suspensa 48 horas antes e após o uso de contraste iodado.

• Fator Etiológico Compartilhado (Conexão com DOC-MED-001): A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS / Pressão Alta) atua como nó de conexão etiológica central no grafo, sendo simultaneamente causa do Infarto Agudo do Miocárdio (DOC-MED-001) e da Nefropatia Diabética Crônica (DOC-MED-005).

Autenticação Digital: Junta Médica de Suporte à Decisão Clínica (GraphRAG & KAG Healthcare) | Registro DOC-MED-005 — Validação Completa.